Module 1 : Repères identitaires et socio-historique de la PA

Cours 1 : Notion de personnes proches aidantes (PPA)

Objectif :

- Se familiariser avec la notion de personnes proches aidantes et ses implications.

PPT narré :

- 20 min narration

Lectures (26):

- CSF : Conseil du statut de la femme (2018) – p.13 à 17, section 1 et 1.1
- Ducharme : Prendre soin d'un parent âgé vulnérable (2012) – p.74 à 78
- Roy : Qui sont les proches aidants et les aidés ? (2019) – no.109 p.11 à 14
- St-Charles et Martin: De la perspective d'aidant naturel à celle de proche soignant. – p.227 à 239

Vidéos – 4 témoignages :

- Line paré (12min)
- J-F Collard (7 min)
- Angèle Doucet et Virginie Carrier (7m30)
- François Lacombe (6m30)
- https://nousprochesaidants.com/#temoignages

Intro

- Le terme PA n'existe pas encore dans le dictionnaire, même si elle a tjrs existée via l'entraide des familles (et non des ressources presque pas présentent).
- Depuis 30 ans, le phénomène est étudié.
- Pourquoi y a-t-il une augmentation de PA ?
    - La majorité des personnes âgés veulent vivre à domicile ou mourir à la maison. (vivre, vieillir, mourir).

L'appui pour les proches aînées sont les 1er à avoir employé le terme PA

Concept de proche aidant : 4 défis

Défi 1 : Nommer la personne (OMS, 2002; St-Charles et Martin, 2001)

- **En anglais**
    - Caregivers Amérique du nord
    - Carers Angleterre
    - Caretakers Inde
- **En français**
    - Aidant naturel, familial ou informel
    - Aidant ultime (Saillant et Gagnon, 2001)
    - Personne-soutien (Lesemann et Nahmiash, 1993)
    - Soignant (Maheu et Guberman, 1992; AFÉAS, 1998)
    - Soignant naturel (Lauzon, 1988)
    - Soignant familial (Ducharme, 1997)
    - Proche-soignant (St-Charles et martin, 2001)
    - Proche-aidant (MSSS, 2003)
- **Question de réflexion :**
    - **Pourquoi la notion « d'aidants naturels » n'est plus utilisée au Québec pour parler de proche aidant?**
        - Naturel, familial, informel ou soignant : cède la place au terme celui de PA.
        - On remet en question le terme naturel dans une perspective féministe.

        - Depuis la fin des années 80, parler d'aide naturelle perpétue la division inégale du travail selon les sexes (les fameuses phrases ''c'est plus naturel pour les femmes'' ☹). Ce qui perpétue la non reconnaissance du travail sous peine que c'est quelque chose de ''naturel''.
        - Ainsi, on minimise le travail (les tâches) des PA en comparaison à ce que font celui des professionnels, alors que ce sont les mêmes tâches (bain, habiller, faire manger…)
        - Dans la littérature et le système de santé, le terme ''naturel'' n'est plus présent. En contraste avec la société et nos familles.
    - **Aidant ultime :** ''aidant principal pour qui l'expérience de la responsabilité est plus marquée par la constance, l'intensité de l'engagement et la proximité du lien avec l'aidé''

Défi 2 : Définir qui le fait et en quoi consiste ce rôle

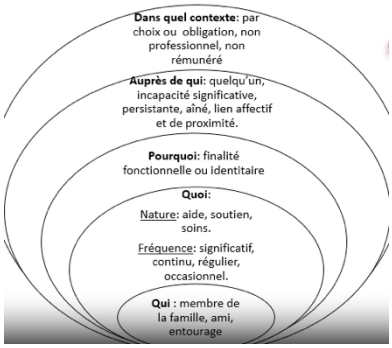
- Membre famille ou un ami qui aide quelqu'un dans l'accomplissement des tâches quotidiennes nécessaires au maintien d'une vie indépendante. **(OMS, 2002)**
    - Définition laissant place à interprétation.
- Toute personne de l'entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne ayant une incapacité est considérée comme un proche-aidant. Il peut s'agir d'un membre de la famille ou d'un ami. **(MSSS, 2003)**
    - Cette définition rajoute la nature et la fréquence du soutient en comparaison à celle de L'OMS.
    - Ceci dit, on ne sait pas c'est quoi un soutien significatif ou une personne avec une incapacité.
        - Ex. si j'aide mon mari suite à un accident de moto à se laver, suis-je PA ? Selon cette définition, oui !
        - Ex. si je prépare des repas congelés pour ma mère âgée suis-je PA ? um plus complexe.
    - Cette définition est utilitariste.
- Finalité fonctionnelle et identitaire **(Gagnon et Saillant, 2004)**
    - Ils ajoutent un élément à la définition de PA, soit une finalité.
    - **Fonctionnelle :** ''satisfaire des besoins de soins, d'accompagnement, d'hygiène''
        - **Aidant professionnel**
    - **Identitaire :** ''maintenir la dignité, l'intégrité et la sécurité de l'aider''
    - On comprend, avec cet ajout, que la tâche d'un PA n'est pas juste un soutien ou l'accomplissement de certaine tâche fonctionnelle…c'est plus que ca. Ca peut être les 2 finalités ou 1.
        - Ex. donner un bain c'est fonctionnelle mais nécessite une dignité et un sentiment de sécurité chez l'aidé Implique les 2 finalités (fonctionnelle et identitaire)
- Relation (proximologie) **(Joublin, 2010)**
    - Il rajoute la relation entre l'aidant et l'aider à la définition de PA.
    - Selon lui, la fonction (donc de rôle et les tâches) ne fait pas la relation.
        - C'est pas pcq'on accompli des tâches avec une personne qu'on créer une relation.
    - Aide à un proche via une proximité affective, mais c'est souvent plus complexe que les professionnels qui n'ont pas une histoire relationnelle antérieure à réparer ou préserver avec l'aidé (autrement dit, ils sont plus neutre).
    - La nature et la qualité de la relation est essentielle à prendre en compte
    - Le rôle d'aidant implique un engagement moral.
- Les personnes proches aidantes assurent volontairement ou par nécessité des soins et des services sans rémunération à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes (accident, handicap, maladie physique ou mentale, vieillissement, etc.) et pour laquelle elles ont un lien affectif (père, mère, conjoint, enfant, frère, soeur, voisin, ami…) **(RANQ, 2010 --- PAQ 2022).**

- Ajoute l'idée qu'être un PA peut-être un choix ou une obligation.

- **Loi 90 : Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé**
  - Un aidant naturel est une personne proche qui fournit sans rémunération des soins et du soutien régulier à une autre personne. **(Éditeur officiel du Québec, 2003, p.10)**
    - Concept de proximité
    - Absence de rémunération
    - Nature du soutien
- **Loi 6 : Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants**
  - Les proches aidants […] fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile. **(Éditeur officiel du Québec, 2009, p.2)**
    - Définition plus restrictive en ne considérant que les proches aînées
- **Loi 56 : Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives**
  - Personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non.Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, et est offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable, dans le but, notamment, de favoriser le rétablissement de la personne aidée et le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie. Il peut prendre diverses formes, par exemple le transport, l'aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel ou la coordination des soins et des services. Il peut également entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. **(Éditeur officiel du Québec, 2020, p.6)**
  - **5 forces de cette définition :**
    1. On prend en compte la nature du soutien (continu, occasionnel, court, long terme)
    2. On met l'accent sur l'aspect relationnel (lien affectif, familial ou non)
    3. On mentionne que le soutien est non professionnel, on précise qu'il se fait dans un cadre informel (**excluant ainsi les bénévoles d'organismes communautaires)
    4. On mentionne que le soutien s'adresse à n'importe qui qui en a besoin peu importe son âge, son lieu de vie, la nature de son incapacité
    5. On donne des exemples de soutien (transport, soin personnel, émotionnel,
  - **4 points innovateurs de cette définition :**
    1. Cette décision doit être libre, éclairée et révocable
    2. Elle précise son but, soit le rétablissement, maintient et amélioration de la qualité de vie du proche
    3. Elle précise les milieux de vie de l'aidé, soit à domicile ou autre
    4. Elle soulève les répercussions possible de la PA, soit impact financier, santé physique, mentale et sur les responsabilités sociales et familiales

Questions à se poser pour déterminer la nature d'un PA

1. **Qui ?**
   a. membre de la famille, ami, entourage
2. **Quoi ?**
   a. Nature : aide, soutien, soins
   b. Fréquence : significatif, continu, régulier, occasionnel



3. **Pourquoi ?**
    a. Finalité fonctionnelle OU identitaire
4. **Auprès de qui ?**
    a. Quelqu'un, incapacité significative, persistante, ainé, lien affectif et de proximité
5. **Dans quel contexte ?**
    a. Par choix OU obligation, non professionnel, non rémunéré

Défi 3 : Décrire les caractéristiques de ce rôle

Aspects visibles et tangibles : identifier, quantifier et décrire les tâches

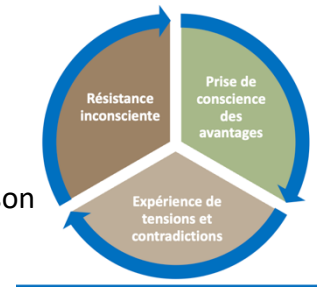
- Ex. donner le bain, faire manger, changer une culotte d'incontinence, aider à se déplacer, s'asseoir, se lever
- Aspects utilisés pour parler de la PA il y a de cela 50 ans.
- Depuis, il y a eu des recherches sur le sujet dans les années 70 pour aider à identifier et quantifier les tâches des PA.
    - Émergences d'aspects négatifs de la PA qui amènent les chercheurs à décrire les tâches et les impacts des PA. (années 80)
    - Ex. Stress, coping, travail de soin, carrière d'aidant
    - On ne se demande ce dont ont besoins les PA, slm focus sur pts -

Aspects invisibles et intangibles : comprendre la relation

- Années 90, on se penche sur les aspect moins tangible (qu'on ne voit pas et ne peut pas mesurer)
    - Ex. l'amour, la tendresse, la confiance, sentiment de sécurité, d'abandon
- On constate l'ampleur de la responsabilité morale des PA et les aspects + associés
    - Ex. la réciprocité, le don de soi, l'accomplissement personnel, la création de nouveau lien, le sentiment de compétence personnelle, ''simplement nous faire du bien''
- Il peut aussi y avoir des aspects – dans les aspects intangibles & + dans les tâches plus techniques (tangibles)

Défi 4 : Se reconnaître dans ce rôle

Le plus grand défi



Processus d'identification au rôle (O'Connor, 2007)

1. **Résistance inconsciente**
    - Reconnaître son rôle, c'est reconnaître l'irréversibilité de la condition de l'aîné ou son degré d'indépendance.
    - Donc naturellement, d'emblée, on résiste à cela.
2. **Prise de conscience des avantages**
    - Ex. un soutien de l'entourage, de la gratification, des services d'aide ou soutien financier
3. **Expériences de tensions et contradictions**
    - Ex. culpabilité., remords, sentiments de prendre le contrôle de la vie de son proche

- Se reconnaître comme PA est un processus cognitif complexe qui peut prendre du temps pour certains et ne jamais se faire complètement pour d'autres.

Avantages de l'auto-reconnaissance (Girard-Marcil et Reiss, 2023)

1. **Prendre conscience de son rôle, de ses responsabilités et de leurs conséquences :**
    - Accéder et utiliser des services
    - Reconnaitre ses besoins et les considérer légitimes
    - S'inscrire dans une communauté plus large : diminue le sentiment d'isolement

Défis de l'auto-reconnaissance (Girard-Marcil et Reiss, 2023)

1. **Associer ce rôle à un fardeau**
    - Dévaloriser la relation sociale et humaine : déviant charge et obligation

- Cristalliser le proche dans une identité “d’aidée” ouvre la voie à une déshumanisation car l’aidé est considéré à travers son incapacité et son besoin de soutien

2. **Considérer ses besoins de PPA comme moins importants** Ils ont peur qu’on délaisse les besoins de leurs proche (aidée) qui sont (selon les PPA) plus grand que les leurs.
3. **Obliger l’identification au rôle :**
   - Préférer rester parent, partenaire, enfant

Le souhait ultime :

- Que les PPA se reconnaissent afin de leur donner accès à des services
- Mais, cette auto-reconnaissance comporte des défis.

Les défis de l’auto reconnaissance :

1 - Pour certains auteurs, le terme «PPA » renvoie directement à la notion de **fardeau**. L’utilisation de ce terme viendrait alors **dévaloriser une relation sociale et humaine** en mettant **l’emphase sur la charge** et **l’obligation** qui y sont associées.
- Aussi, pour qu’il y ait une personne proche aidante, il faut qu’il y ait **une personne aidée**. Ainsi, cette
2 appellation risque de **cristalliser la personne dans une identité « d’aidée »** ce qui peut **dépersonnaliser** la personne soutenue et ouvrir la voie à une certaine **déshumanisation**, **la personne aidée** n’étant considérée que principalement à travers son incapacité et son besoin de soutien.
2 - Si s’autoreconnaitre comme PPA peut permettre de prendre conscience de ses propres **besoins**, **certaines PPA auront tendance à les banaliser** ou à les considérer moins importants que ceux de la personne aidée donc de ne pas en parler aux professionnels.
3 - De plus, **vouloir faciliter l’autoreconnaissance peut engendrer des risques si la volonté des personnes n’est pas respectée.** Il n’est pas rare qu’une PPA prenne conscience de son rôle lors d’une discussion avec un professionnel ou son entourage. Or, elle peut préférer se qualifier autrement comme parent, enfant ou partenaire et ne pas souhaiter se faire assigner le titre de PPA. **Qualifier une personne avec une étiquette qu’elle ne souhaite pas porter, ou forcer l’autoreconnaissance, peut avoir des conséquences négatives sur sa santé mentale.**

Vidéos

Line Paré

- Mère d’une fille qui a été élevé par ses grands-parents (parents de Line) et ses tantes (famille).
- Line habite à St-Anne de Beaupré
- Souffre d’une déficience visuelle (maladie). Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir une vie heureuse, grâce à son entourage ☺.
- Syndrome de Rieger (rare) :
  - Le syndrome/anomalie d’Axenfeld-Rieger (SAR) est une maladie rare, d’origine génétique, regroupant plusieurs affections, cliniquement et génétiquement hétérogènes. Cette dysgénésie du segment antérieur de l'œil.
  - Maladie de l’œil.
- Soutient des parents :
  - Mère : dédramatisait, ‘’tjrs parfait’’
- Déclin du soutien de sa mère en lien avec sa vieillesse durant 3 ans :
  - Changement de comportement : oublie, habitude quotidienne changeante
  - Problèmes cognitifs qui lui génèrent de la colère.
  - Impact sur son aide à Line
- Line prend un cour des proches aidants pour soutenir sa mère :
  - Alzheimer
  - Impact de la médication, soutien entre PA, comment l’hébergement fonctionne, comprendre les changements de comportements chez sa mère, …

- Élément déclencheur (2010) :
    - Mère prend un chaudron avec de l'eau bouillante et veut le lancer sur Line et sa tante
- Incompréhension de la mère :
    - Elle ne comprend pas pourquoi elle est placé en hébergement, elle vie de la colère envers Line (sa fille) qu'elle dit ne jamais l'avoir placé pour sa maladie
- L'état de sa tante dégénère suite au placement de la mère de Line en 2010 :
    - Oublie, perdre ses objets, jette ses vêtements, joue dans les fusibles…
    - Développe des comportements dangereux.
- Départ de la tante la journée de la fête à Line :
    - Line est émotive de cela
    - Elle n'était pas présente lors du départ, son cousin s'en était occupé.
    - Pour faciliter la transition, ils disent que l'appartement va subir des rénovations et qu'en attendant ils lui ont trouvé une place où il y a des activités, … Bref, elle achète l'idée.
- Line aura été PA pour sa tante (mort 2016) et sa mère (mort 2014)
- Difficultés depuis la mort des 2 :
    - La solitude lors du souper qui génère moins d'appétit.
    - Elle a tjrs été automne pour aller à la caisse. Passer par le boulevard. Maintenant il y a une piste cyclable, soit un nouvel obstacle qui devient handicapant pour elle à cause de la clôture.
    - Réalisation de qui a été là pour elle lors d'obstacle; sentiment de reconnaissance (non nommé).

Jean-Francois Collard

- Retraité depuis 14 ans, déménagé à Sherbrooke pour s'occuper de sa mère et son beau-père via l'achat d'une maison et sa rénovation (son projet de retraite)
- L'aide se fait tranquillement avec le temps et les besoins changeants :
    - Commence à créer un sentiment d'insécurité/peur (non-dit)
- Augmentation des besoins en 2014 :
    - Beau-père reçoit un diagnostic terminal de cancer dont il décède en 2016
    - J-F s'en occupe durant 2 ans
- Difficulté :
    - Sentiment de solitude (''seul au monde'')
    - Pression sur le dos pcq le b-p n'a confiance qu'en lui
- Élément aidant :
    - Infirmière pivot informe J-F d'un programme d'appui des PA via le CLSC
- Mère de J-F & défis :
    - Mal entendante depuis 20 ans
    - J-F confond parfois cette maladie à un début d'Alzheimer (ne comprend pas tjrs bien, écouter lui demande bcp d'efforts)
    - J-F trouve son rôle PA difficile, il doit monter le ton verbal pour qu'elle l'entende mais parfois se fâche pcq c'est trop fort. Elle est anxieuse (crise d'anxiété).
    - Il ne veut pas habiter avec elle, vice-versa non plus. Il l'a voit tous les dimanches, maintenant 2-3 fois par semaines.
    - J-F apprend a devenir à l'écoute et se détacher émotionnellement (ne pas ramener à la maison) et ce grâce aux conférences données pour les PA.
    - Pour s'aider il va faire des cours de zumba pour décrocher.
    - Rencontre de paires lors des rencontres PA, dont 2 hommes (rare se font les hommes PA, ce sont surtout les femmes).
- Selon J-F, c'est la moindre des choses que d'offrir 1h par jour, même si parfois il trouve ça lourd ça fait partie de ses valeurs (sentiment de satisfaction du travail qu'il a fait et veut que ça soit la même chose pour sa mère).

Angèle Doucet et Virginie Carrier

- 32 ans, 3 enfants (en bas de 10 ans), infirmière practicienne, en couple depusi 12, bigénération depuis 4 ans
- SLA diagnostique du père de Virginie, espérance de 2-5 ans, dégénération rapide, paralysie
- Construction d'une maison bigénérationnelle
    - Angèle (mère), métier enseignante prend un temps avant d'accepter cette solution
    - Tlm embarque dans le projet
- Effet + :
    - Pas d'isolement ce qui aide sa santé
    - Tjrs du mouvement, de l'action surtout avec les enfants
    - Au quotidien c'est un plus pour tlm (Arena hockey présence de papi, heure du diner, …)
    - Entraide commune :
        - la mère s'occupe des midis des enfants lorsque virginie travail
        - Virginie se renseigne sur la SLA (infirmière)
        - Accompagne son père au RDV chez la neurologue
- Réaction suite au dx :
    - Son père ne comprend pas au début, mais vit un soulagement de mettre des mots sur ce qu'il a
    - Virginie est stressé (mordille joue)
- La maladie évolue lentement

François Lacombe

- Préposé au bénéficiaires en soin de longue durée
- Sa mère, Diane, bonne relation, vivent proche l'un de l'autre
- Il déménage en face de ses parents lorsque son père est atteint d'un cancer de la vessie. Sa mère s'est occupé de son mari durant cette période et en soutient leur fils François.
    - Mobilisation du père via force (soulever le mari)
- C'est mieux et beau d'être PA et de laisser son parent à la maison. François ne veut pas placer ses parents.
- Élément déclencheur :
    - Sa mère tombe malade (sclérose : dégradation rapide).
        - La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) touche 6 à 8 personnes sur 100 000 par an.
        - Cette maladie neuromusculaire se caractérise par la dégénérescence d'un ensemble de cellules nerveuses et de voies de signalisation dans le cerveau et la moelle épinière, ce qui entraîne une paralysie progressive des muscles.
        - Le pronostic vital est en moyenne de 2 à 5 ans après le diagnostic.
    - AVQ commence à être difficile pour sa mère.
- Difficile financièrement pour François de garder sa mère :
    - Demande un congé sabbatique à traitement différé (son emploi lui y donne accès pour s'occuper se sa mère)
        - Le congé sabbatique à traitement différé (CSTD) permet à un employé de prendre un congé payé d'un an dans le cadre d'une entente avec son employeur.
        - Par exemple, si un employé a un salaire annuel de 45 000$, il peut différer 10 000$ de son salaire pendant 3 ans, lui assurant un salaire de 30 000$ durant son arrêt de travail.
        - Pour que les avantages du CSTD soient reconnus, la personne doit respecter toutes les conditions suivantes :
            - Avoir droit à cette mesure d'après ses conditions de travail
            - Conclure une entente avec son employeur

- Avoir à son crédit au moins 36 mois de service pour l'admissibilité chez un ou des employeurs assujettis à l'un des régimes de retraite du secteur public qui seront administrés auprès de son employeur
- Différer une partie de son salaire pendant un maximum de 4,5 années
- Prendre un congé d'au plus 1 an pendant l'entente
- Respecter les règles fiscales.

- Sans le congé, il aura du placer sa mère.
    - Sa mère a besoin d'aide pour sortir du lit, s'habiller, …
    - Le congé lui permet de passer les journées avec sa mère.
- Selon lui être PA est enrichissant, c'est très demandant au niveau émotionnelle et psychologique.
    - La vie change, elle ne veut plus invité les gens à faire des souper.
    - Capacité d'adaptation.
    - Malgré ce qu'on peut perdre, y'a plus de positif de rester avec sa mère comme PA.
    - ''Un jour à la fois''

Références

Éditeur officiel du Québec. (2020, 28 octobre). Projet de loi no 56 : Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives.

Éditeur officiel du Québec (2009, 27 octobre). Projet de loi no 6: Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants.

Éditeur officiel du Québec (2002, 14 juin). Loi 90 : Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé.

Gagnon, É. et Saillant, F. (2004). Sources et figures de la responsabilité aujourd'hui. Éthique publique, 6(1), 41-55.

Girard-Marcil, C. et Reiss, M. (2023). La reconnaissance et l'autoreconnaissance des personnes proches aidantes : enjeux et pratiques. Observatoire québécois de la proche aidance, Direction des affaires académiques et de l'éthique de la recherche, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.
Joublin, H. (2010). Le proche de la personne malade dans l'univers des soins. Enjeux éthiques de proximologie. Éres.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2003). Chez soi : le premier choix : la politique de soutien à domicile.
La politique de soutien à domicile. Gouvernement du Québec: Direction des communications.

O'Connor, L. D. (2007). Self-identifying as a caregiver: Exploring the positioning process. Journal of Aging Studies 21, 165–174.
OMS (2002). Current and Future Long-Term Care Needs. An Analysis Based on the 1990 WHO study, The Global Burden of Disease, and the International Classification of Functioning, Disability and Health Organization.

St-Charles, D. et Martin, J.-C. (2001). De la perspective «d'aidant naturel» à celle de «proche aidant» : un passage nécessaire. Santé mentale au Québec, 26(2), 227-244.